

Relatório Genômico Reprodutivo

Triagem de portadores individual e integrada do casal

TIPO MODELO EDITÁVEL	ESCOPO REUTILIZÁVEL	DADOS PESSOAIS NÃO INSERIDOS
-------------------------	------------------------	---------------------------------

Finalidade

Organizar triagem de portadores, risco combinado do casal, herança, risco residual e opções reprodutivas sem confundir screening com diagnóstico.

Público

Pessoa/casal, geneticista, obstetra, reprodução assistida e aconselhamento genético

MODELO — NÃO É RESULTADO GENÉTICO

Este documento contém campos e orientações para futura geração de relatórios. Nenhuma variante, origem, risco, parentesco, recomendação ou confirmação pessoal foi inferida nesta entrega.

Identificação e controle

Pessoa/ID	[[NOME_OU_ID_PSEUDONIMIZADO]]
Data de nascimento	[[DATA_NASCIMENTO_OU_NAO_INFORMADA]]
Solicitante	[[PROFISSIONAL_OU_SERVICO_SOLICITANTE]]
Amostra	[[TIPO_AMOSTRA_E_IDENTIFICADOR]]
Laboratório/plataforma	[[LABORATORIO_E_PLATAFORMA]]
Data da coleta	[[DATA_COLETA]]
Data de emissão	[[DATA_EMISSAO]]
Versão do relatório	[[VERSAO_RELATORIO]]

Preenchimento seguro

Substitua cada [[CAMPO]] por dado rastreável. Quando um dado exigido não existir, use NÃO DISPONÍVEL e explique o impacto; nunca improvise um valor.

Perguntas que este relatório responde

1. Cada parceiro foi analisado no mesmo escopo e com cobertura comparavel?
2. Existe gene/condição compartilhado com risco reprodutivo aumentado?
3. Qual e o risco residual após um resultado negativo?
4. Que confirmação e aconselhamento precedem qualquer decisão?

Como ler

Eixo	Valores permitidos	Uso
Natureza	FATO CONFIRMADO • INFERÊNCIA • ASSOCIAÇÃO • HIPÓTESE • DESCONHECIDO	Força lógica da afirmação
Domínio	CLÍNICO • PREDISPOSIÇÃO • PESQUISA • CURIOSIDADE	Uso pretendido
Operação	EXECUTADO • VERIFICADO • INFERIDO • PROPOSTO • NÃO DISPONÍVEL	O que realmente ocorreu
Prioridade	P1 • P2 • P3 • P4 • P5	Ordem de atenção, não gravidade isolada

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Consentimento, privacidade e escopo

Consentimento e versão	[[ID_VERSAO_DATA_CONSENTIMENTO]]
Finalidade autorizada	[[FINALIDADE_E_RELATORIOS_AUTORIZADOS]]
Achados secundários	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Dados familiares/parentesco	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Recontato/reanálise	[[PREFERENCIA_CANAL_PRAZO]]
Destinatários	[[PESSOAS_SERVICOS_AUTORIZADOS]]
Retenção/eliminação	[[POLITICA_E_PRAZO]]

Dados familiares também são sensíveis

Minimize identificadores, registre o fundamento de compartilhamento e antecipe resultados inesperados que possam afetar parentes não testados.

1. Resumo para o casal

Apresente primeiro o risco combinado, depois os achados individuais e, por fim, as limitações.

Pares gene-condição [[N_PARES_RELEVANTES]] Após harmonizacão do escopo	Portadores A [[N_PORTADOR_A]] Variantes reportáveis
Portadores B [[N_PORTADOR_B]] Variantes reportáveis	Risco residual [[FAIXA_RESIDUAL]] Específico por condição

Decisões prioritárias

Condição	Padrão de herança	Pessoa A	Pessoa B	Risco por gestação	Confirmação	Aconselhamento	Status
[[CONDICAO_GENE]]	[[AR_XL_AD_MT_OUTRO]]	[[GENOTIPO]]	[[GENOTIPO]]	[[RISCO_E_PRESUPOSTOS]]	[[METODO]]	[[ENCAMINHAMENTO]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Triagem não é diagnóstico fetal

Carrier screening estima risco antes ou durante a gestação. NIPT/cfDNA é rastreamento, enquanto CVS/amniocentese com teste apropriado pode ser diagnóstico; o método indicado depende do caso.

2. Escopo individual e comparabilidade

Resultados do casal só podem ser integrados após alinhar genes, transcritos, classes de variantes, cobertura, CNV, repetições e limitações.

Elemento	Pessoa A	Pessoa B	Comparavel?	Ação corretiva
Painel/genes	[[ESCOPO_A]]	[[ESCOPO_B]]	[[SIM_NAO_PARCIAL]]	[[COMPLEMENTAR]]
SNV/indel	[[COBERTURA_A]]	[[COBERTURA_B]]	[[STATUS]]	[[ACA0]]
CNV/SV	[[COBERTURA_A]]	[[COBERTURA_B]]	[[STATUS]]	[[ACA0]]
Repetições/ pseudogenes	[[COBERTURA_A]]	[[COBERTURA_B]]	[[STATUS]]	[[ACA0]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Consanguinidade declarada/estimada	[[DADO_E_METODO]]
Ancestralidade relevante ao residual	[[CONTEXTO_SE_VALIDO]]
Histórico reprodutivo	[[GESTACOES_PERDAS_DIAGNOSTICOS]]
Doadores/parentesco biológico	[[CONTEXTO_CONSENTIDO]]

3. Achados de portador por pessoa

Cada variante deve ter nomenclatura, classificação, evidência, herança, fase quando relevante e qualidade analítica.

Pessoa A

Gene/ transcrito	Variante	Zigossidade	Condição	Herança	Classificação	Qualidade	Confirmação
[[GENE_MANE]]	[[HGVS]]	[[ZIGOSIDADE]]	[[CONDICAO]]	[[PADRAO]]	[[CLASSE_CRITERIOS]]	[[QC]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Pessoa B

Gene/ transcrito	Variante	Zigossidade	Condição	Herança	Classificação	Qualidade	Confirmação
[[GENE_MANE]]	[[HGVS]]	[[ZIGOSIDADE]]	[[CONDICAO]]	[[PADRAO]]	[[CLASSE_CRITERIOS]]	[[QC]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

4. Risco combinado e fase

Calcular por condição e modo de herança. Em variantes no mesmo gene, documentar cis/trans ou a necessidade de fase parental.

Cenário	Hipoteses	Risco concepcional	Risco residual	Penetrância/expressividade	Incerteza
Autossômico recessivo	[[AMBOS_PORTADORES_E_FASE]]	[[RISCO_POR_GESTACAO]]	[[RESIDUAL]]	[[VARIABILIDADE]]	[[LACUNAS]]
Ligado ao X	[[SEXO_GENETICO_E_PORTADOR]]	[[RISCO_POR_GESTACAO]]	[[RESIDUAL]]	[[VARIABILIDADE]]	[[LACUNAS]]
Dominante/mitocondrial/outro	[[PRESSUPOSTOS]]	[[RISCO]]	[[RESIDUAL]]	[[PENETRANCIA]]	[[LACUNAS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Risco residual nunca é zero

Um resultado negativo reduz o risco somente para variantes e classes detectáveis no escopo. Use prevalência, taxa de detecção por população e limitações do ensaio para estimar o residual.

5. Opções e jornada de decisão

Expor opções de forma não diretiva, respeitando valores, tempo, acesso, idade gestacional e aconselhamento especializado.

Opção	Quando considerar	O que responde	Limites/riscos	Dependencias
Concepção natural + diagnóstico pre-natal	[[CENARIO]]	[[ALVO_DIAGNOSTICO]]	[[LIMITES]]	[[CONFIRMACAO_VARIANTES]]
FIV + PGT-M	[[CENARIO]]	[[ALVO_FAMILIAR]]	[[LIMITES]]	[[DESENHO_E_VALIDACAO]]
Gametas/embriao doado	[[CENARIO]]	[[REDUCAO_DE_RISCO]]	[[ASPECTOS]]	[[ACONSELHAMENTO]]
Não prosseguir/adiar/outras	[[PREFERENCIA]]	[[OBJETIVO]]	[[ASPECTOS]]	[[SUPORTE]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

PGT poligênico

Não apresentar PGT-P como pratica clínica estabelecida. Separar claramente de PGT-M e registrar incertezas de validade, equidade, pleiotropia e utilidade.

6. Plano e comunicação familiar

Defina confirmação, teste do parceiro/familiares, aconselhamento, prazo reprodutivo e documento para o laboratório.

Ação	Pessoa	Responsável	Prazo	Pre-requisito	Status
[[ACA0]]	[[A_B_CASAL_FAMILIAR]]	[[RESPONSAVEL]]	[[PRAZO]]	[[DEPENDENCIA]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Limitações, confirmação e segurança

Tema	Declaração obrigatória
Escopo	[[GENES_REGIOES_CLASSES_E_POPULACAO_COBERTOS]]
Pontos cegos	[[REGIOES_CLASSES_VAF_FASE_E_MECANISMOS_NAO_AVALIADOS]]
Confirmação	[[ACHADOS_QUE_EXIGEM_METODO_ORTOGONAL_E_SEGREGACAO]]
Incerteza	[[VUS_CONFLITOS_PENETRANCIA_E_LIMITES_DE_MODELO]]
Temporalidade	[[DATA_LIMITE_DE_BANCOS_GUIDELINES_E_REANALISE]]
Uso clínico	[[PROFISSIONAIS_E_DECISoes_FORA_DO_ESCOPo]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Resultado negativo é contextual

A ausência de achado reportável só informa o escopo que atingiu qualidade suficiente e as classes efetivamente executadas. Risco residual e teste complementar devem ficar visíveis.

Fontes-base e versões

Fontes consultadas para o desenho do modelo em 15/08/2026. Em um relatório preenchido, citar a fonte específica junto de cada afirmação e registrar a versão/data efetivamente usada.

[ACMG_CARRIER] ACMG (2021). Screening for autosomal recessive and X-linked conditions during pregnancy and preconception. [Abrir fonte oficial](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8488021/) (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8488021/)

[ACOG_CFDNA] ACOG (2026). Screening for Fetal Chromosomal Abnormalities. [Abrir fonte oficial](https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2026/01/screening-for-fetal-chromosomal-abnormalities) (https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2026/01/screening-for-fetal-chromosomal-abnormalities)

[ASRM_PGTM] ASRM (2023). Indications and management of PGT for monogenic conditions. [Abrir fonte oficial](https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/indications-and-management-of-preimplantation-genetic-testing-for-monogenic-conditions-a-committee-opinion-2023/) (https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/indications-and-management-of-preimplantation-genetic-testing-for-monogenic-conditions-a-committee-opinion-2023/)

[ASRM_PGTP] ASRM (2026). Use of PGT for polygenic disorders. [Abrir fonte oficial](https://www.asrm.org/practice-guidance/ethics-opinions/use-of-preimplantation-genetic-testing-for-polygenic-disorders-pgt-p-an-ethics-committee-opinion-2026/) (https://www.asrm.org/practice-guidance/ethics-opinions/use-of-preimplantation-genetic-testing-for-polygenic-disorders-pgt-p-an-ethics-committee-opinion-2026/)

[ACMG_AMP] ACMG/AMP (2015). Standards and Guidelines for the Interpretation of Sequence Variants. [Abrir fonte oficial](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4544753/) (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4544753/)

[CLINVAR] NCBI (base continuamente atualizada). ClinVar. [Abrir fonte oficial](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/)

[GNOMAD] Broad Institute (2026). gnomAD v4.1.1. [Abrir fonte oficial](https://gnomad.broadinstitute.org/news/2026-03-gnomad-v4-1-1/) (https://gnomad.broadinstitute.org/news/2026-03-gnomad-v4-1-1/)

Execution Manifest do relatório preenchido

Componente	Evidência/artefato	Responsável	Data	Status
Ruleset	GENOMA-RULESET v3.4 — VIGENTE — 17/08/2026	Sistema/revisor	15/08/2026	VERIFICADO
Entradas e hashes	[[MANIFESTO_DE_ENTRADAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
QC e cobertura	[[RELATORIO_QC]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Pipeline/análises	[[LOGS_WORKFLOW_VERSIONES]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Fontes e curadoria	[[REGISTRO_DE_CONSULTAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Confirmação laboratorial	[[LAUDO_OU_NAO_DISPONIVEL]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Revisão clínica/técnica	[[ASSINATURAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Changelog

Versão	Data	Alteração	Impacto	Autor/revisor
[[VERSAO]]	[[DATA]]	[[MUDANCA]]	[[SECOES_RESULTADOS_A_FETADOS]]	[[IDENTIFICACAO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Estado desta entrega

MODELO GERADO: EXECUTADO. PESQUISA DE FONTES: EXECUTADO/VERIFICADO. ANÁLISE GENÉTICA PESSOAL: NÃO DISPONÍVEL NESTA ENTREGA. CONFIRMAÇÃO CLÍNICA: NÃO DISPONÍVEL. POST-DEPLOYMENT: PENDENTE.

Declaração de uso: modelo informativo e editorial; não constitui laudo, diagnóstico, aconselhamento individual ou prescrição.